

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5065360-79.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: TANIA MARIA PINHEIRO DE MENDONCA
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

PROCESSO CIVIL E SAÚDE - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1ª INSTANCIA REVISTA ANTE A PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - ART 937 DO CPC - NEOPLASIA DE TIREEÓIDE - INSCRIÇÃO NO SER REALIZADA EM 27/03/2024 - TRATAMENTO AINDA NÃO INICIADO - RISCO VERMELHO - PRIORIDADE 1 - PRAZO LEGAL PARA INÍCIO DO TRATAMENTO ULTRAPASSADO - LEI Nº 12.732/2012 - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REVISTA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, confirmando a tutela deferida no Evento 5 destes autos, para que os agravados providenciem a Consulta/ Ambulatório 1ª Vez Neoplasias da Tireoide (Oncologia) em favor da autora no prazo máximo de 20 dias corridos contados da intimação. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2024.

5065360-79.2024.4.02.5101

510014223451 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5065360-79.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: TANIA MARIA PINHEIRO DE MENDONCA
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

O presente recurso foi interposto pela parte autora em face de decisão do juizado especial de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A parte autora, **idosa de 64 anos**, foi diagnosticada com **Neoplasia maligna da glândula tireóide** (CID 10 C73), conforme exame citológico liberado em **20/03/2024**, sendo **encaminhada para Ambulatório 1ª vez - Neoplasias da Tireoide (Oncologia) em 10/04/2024** e inserida no Sistema Estadual de Regulação - SER. Conforme Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF), **realizada em 28/02/2024, foi confirmada a presença de nódulo** misto sólido-cístico, com calcificações grosseiras intranodulares, medindo 22x17x13mm, localizado no terço inferior do lobo direito. A partir disso, o exame citológico concluiu pela suspeição de Neoplasia folicular. Diante do exposto, houve o encaminhamento para oncologia clínica e a autora foi inserida no Sistema Estadual de Regulação para consulta em Ambulatório 1ª vez - Neoplasias da Tireoide (Oncologia), sob o ID 5380729 no dia 27/03/2024. Apresentado o caso à Câmara de Resolução de Litígios de Saúde (CRLS), foi exarado Parecer Técnico nº SES/SJ/CRLS nº 106682/2024, em 12/08/2024, **dando conta de que a parte autora encontra-se EM FILA desde 27/03/2024, ainda estando na colocação 40** e, no momento, **não há vaga disponível para a regulação da demanda pleiteada.**

A decisão de 1ª instância foi revista por atender não aos parâmetros fixados pela lei.

Apresentadas contrarrazões, vieram conclusos.

O MPF manifestou-se pela ausência de interesse na sua intervenção no feito.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analisando o processo em 1ª instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

O juízo indeferiu o pedido liminar sob o seguinte fundamento: *"Apenas para que fique claro, se ainda **não restou evidente até aqui, o subscritor desta decisão afirma não haver direito subjetivo individual** a prestações de saúde por parte do Estado, o que não quer dizer que não exista o direito difuso correspondente ou que esteja de uma vez abdicando do exame de cada caso particular quando outros direitos conexos possam exigir prestação de tal natureza. Por isso mesmo, esta é uma decisão de caráter geral e de texto padronizado, aplicada em todos os casos nos quais nenhuma peculiaridade exija um pronunciamento específico."*

A parte autora apresentou exame de citologia realizado em 29/02/2024 e liberado em 20/03/2024 (fl. 10 do evento 1, ANEXO2), no qual consta a seguinte conclusão: "Categoria IV de Bethesda: suspeito para Neoplasia folicular." Anexou encaminhamento da SMSRJ para consulta em cirurgia de cabeça e pescoço em oncologia por nódulo de tireoide com neoplasia folicular para avaliação, datado de 10/04/2024 (fl. 11 do evento 1, ANEXO2).

O caso foi submetido previamente à Câmara de Resolução de Litígios em Saúde - CRLS, qual apresentou as seguintes ponderações: *"Trata-se de assistida com suspeita diagnóstica de neoplasia folicular de tireoide. O câncer folicular de tireoide é responsável por aproximadamente 4% de todos os casos de câncer de tireoide e é mais frequente em adultos mais velhos; também é mais comum em regiões onde a deficiência de iodo é mais comum. Apresenta exame anatomopatológico compatível com neoplasia folicular de tireoide. Aguardando consulta oncológica. Recurso: Ambulatório 1ª vez Neoplasias da Tireoide (Oncologia). (...) Informa-se que as vagas disponíveis para a demanda pleiteada são reguladas pelo Sistema Estadual de Regulação (SER). Após consulta ao referido sistema, **cumprir informar que a assistida encontra-se sob situação atual: EM FILA para Ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia), desde 27/03/2024.** Considerando a Lei 12.732/2012, de 22 de novembro de 2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início, prevendo que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único."*

Portanto, conforme se extrai da documentação apresentada, a autora possui diagnóstico de neoplasia de tireoide desde 27/03/2024 e já se passaram mais de 150 dias sem sua submissão ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), confrontando a Lei nº 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada deve se dar em 60 dias:

"Art. 1º O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei.

Parágrafo único. A padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e republicada, e atualizada sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados.

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.

§ 2º Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos.

§ 3º Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. **(Incluído pela Lei nº 13.896, de 2019)** "

Transcorrido o prazo máximo de 60 dias fixado pela Lei nº 12.732/2012 sem o início do primeiro tratamento oncológico, presume-se negligência e falha no serviço da Administração Pública, apta a autorizar a intervenção judicial, pois evidencia a probabilidade do direito, na forma do art. 300 do CPC/2015.

No presente caso, a falha do Estado manifesta-se pelo decurso de mais de 60 dias início do primeiro tratamento oncológico, o qual é indicado por laudo de médico do SUS.

Ou seja, nem a camara de solução de conflitos da DPU nem o proprio ERJ negam o direito da parte autora. A questão é que, aparentemente, não existem leitos ou vagas. Ou seja, o direito é reconhecido na lei mas não tem como ser cumprido. Não há como retirar um paciente de um leito para colocar a parte autora, razão pela qual a medida será concedida, porque o direito indubitavelmente existe na lei, mas não se vê como será cumprido. Daí a necessaria intimação do MPF para que atue junto aos entes publicos no sentido de viabilizar o direito, como deveria ser assegurado a todos os cidadãos.

O NAT apresentou parecer (evento 20, PARECER1) esclarecendo que a Consulta/ Ambulatório 1ª Vez Neoplasias da Tireoide (Oncologia) e tratamento oncológico estão indicados ao manejo da condição clínica da Autora - neoplasia maligna de tiroide (Evento 1, ANEXO2, Página 11). Além disso, estão cobertos pelo SUS, conforme a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS (SIGTAP), na qual constam: consulta médica em atenção especializada, tratamento clínico de paciente oncológico, sob os seguintes códigos de procedimento: 03.03.13.006-7, 03.04.10.002-1, considerando o disposto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES).

Por fim, ressaltou a demora além do prazo legal no atendimento do caso da autora, pois, em consulta à plataforma do Sistema Estadual de Regulação - SER, foi localizado para a Autora solicitação de Consulta - Ambulatório 1ª vez - Neoplasias da Tireoide (Oncologia), **solicitado em 27/03/2024**, pelo Centro Municipal de Saúde Carlos Gentile De Mello, CID: Neoplasia maligna da glândula tireoide, **classificação de risco Vermelho: prioridade 1, situação: Em fila, posição 6º. O parecer é de 30/08/2024.**

Sobre o questionamento acerca da urgência, gravidade e possibilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da Autora, destacou que, de acordo com documentos médicos acostados ao processo (Evento 1, ANEXO2, Páginas 9 a 11), a doença da Autora foi classificada como categoria IV de Bethesda, TI-RADS 4 e Chammas III, que representa achados suspeitos de malignidade. Assim, ressaltou que demora exacerbada na realização da consulta oncológica da Autora poderá influenciar negativamente no prognóstico em questão. **Tanto assim que esta na fila de prioridade 1.**

Ante o exposto, **voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, confirmando a tutela deferida no Evento 5 destes autos, para que os agravados providenciem a Consulta/ Ambulatório 1ª Vez Neoplasias da Tireoide (Oncologia) em favor da autora no prazo máximo de 20 dias corridos contados da intimação.** Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.